

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	存留導尿技術 Retention of Catheterization				
編號	A31000-Q05-W-A26	制定者	OR 張婉倩	公布日期	89 年 01 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 04 月 07 日
版本/總頁數	第 3.9 版/9 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 04 月 07 日

一、目的

護理人員能依據 CAUTI Bundle 及洗手五時機，正確操作存留導尿技術。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）技術目的

1. 判斷及監測尿液排出情形。
2. 對於手術後傷口、褥瘡或尿失禁病人保護其會陰周圍皮膚清潔乾燥。
3. 需膀胱沖洗或藥物留置治療。
4. 增加病人舒適度，如：癌症末期病人、長期固定不動（如胸腔或脊椎嚴重外傷或骨盆骨折）、急性尿滯留或尿道阻塞或神經性膀胱。

（二）用物準備

1. 拋棄式導尿包：包裝包布 80×80 cm、不附背膠洞巾 60×60 cm、大棉棒 6 支、醫用紗布 10×10 cm、消毒液盒、Jelly 3ml。
2. 20c.c. 蒸餾水溶液 2 瓶。
3. 優碘溶液或 Aqua 2%CHG 水溶液。
4. 無菌手套 1 雙（尺寸視需要）。
5. 存留導尿管 1 條 16Fr 或 18Fr（尺寸視需要）。
6. 蓄尿袋 1 個。
7. 10 c.c. 空針 1 支。

主題名稱	存留導尿技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A26	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	2/9

8.Mefix。

9.無菌尿盒（視需要）。

10. 酒精棉片 2 片。

11. 無菌鑷子（視需要）。

12. 視需要準備會陰沖洗或清潔物品（沖洗棉枝 1-2 包、沖洗壺、41-43℃溫開水、看護墊或便盆）。

（三）步驟及要點說明

步驟	說明
1. 核對醫囑及病人：	
(1)核對電腦 HIS 系統於護理執行，核對預定執行醫囑，並於核對狀態核簽“正確”。	
(2)正確使用兩種以上辨識方法辨識病人，向病人或家屬解釋（說明目的及步驟）。	確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日等，無法應答者則由家屬（照顧者）說出姓名或核對病歷資料（床頭卡）並核對手圈。
(3)確認同意書是否簽屬完整	
2. 請病人先自行清洗會陰。	若無法自行清洗者則需進行會陰沖洗技術。
3. 備齊並確認用物有效日期後攜至病人單位	
4. 準備環境及病人：	
(1) 關病房門、拉圍簾、掛「治療中請勿打擾」牌子。	
(2) 時機 1 接觸病人前洗手	
(3) 將床尾之被單反折至下腹部適當覆蓋後協助病人脫除褲子。	
(4) 協助女病人採屈膝仰臥式並將兩腳分開。	男病人採平躺仰臥姿勢即可。
(5) 協助病人會陰沖洗或清潔。	請參閱A31000-Q05-W-C08會陰沖洗 ※男病人：（專科護理師或醫師執行為主） 1. 將病人的包皮撥開露出龜頭，一手固定陰莖，另一手拿沖洗壺，再以慣用手拿濕棉枝，由上而下擦拭一圈，清洗乾淨後取一乾棉枝擦乾，將包皮推回。 2. 清洗陰莖及陰囊，撥開陰囊清洗兩側鼠蹊部

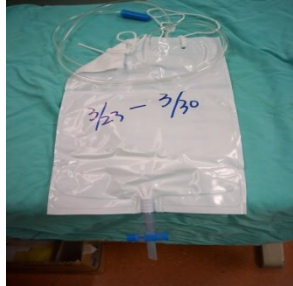
主題名稱	存留導尿技術	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-A26	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	3/9

步驟	說明
	至肛門口。 3. 沖洗乾淨後以棉枝輕輕擦乾，或以衛生紙、毛巾輕拍吸乾水份。 4. 移除便盆或尿布。
(6) 時機 3 暴露病人體液風險後 & 時機 2 執行無菌技術前洗手。	
(7) 導尿包置病人雙腿間且緊靠臀部，以無菌原則打開拋棄式導尿包。	
(8) 視情況請病人雙腿用力踩住床墊以抬高臀部，將包裝包布墊於臀下。	
(9) 拆開導尿管外包裝紙後以無菌方式置於包布無菌區內。	視需要使用無菌鑷子。
(10) 10c.c.空針拆開外包裝紙，以無菌原則置於包布無菌區內。	
(11) 拆除蓄尿袋包裝紙，以無菌原則置於包布無菌區內。	視需要使用無菌鑷子。
(12) 遵循無菌原則分別將優碘溶液及蒸餾水溶液分別倒於雙格消毒液盒中。	20c.c.瓶裝蒸餾水(D/W)溶液瓶口先使用酒精棉片消毒過後再打開。 
5. 以無菌技術執行導尿技術：	
(1) 穿戴無菌手套。	
(2) 以 10c.c.空針從消毒液盒中抽取固定用之蒸餾水。	
(3) 將導尿管由內包裝取出接上蓄尿袋。	
(4) 擠出潤滑劑於紗布中並潤滑導尿管前端女病人	男病人之導尿管需潤滑約 7-8 吋 (17-20 公

主題名稱	存留導尿技術	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-A26	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	4/9

步驟	說明
2-3 吋 (5-7 公分)。	分)。
(5)女病人之步驟： A. 鋪無菌洞巾，使女病人會陰部露出洞巾之洞口。 B. 以一手大拇指及食指分開女病人小陰唇露出尿道口（完成導尿之過程中不可換手）。 C. 消毒：一手持大棉棒，由上往下消毒尿道口，優碘消毒時間需停留 2 分鐘，步驟如下： (a)持第 1 支棉棒，消毒遠端之小陰唇內面，並將用過之棉棒丟至無菌手套包裝廢紙上。 (b)持第 2 支棉棒消毒近端之小陰唇內面。 (c)持第 3 支棉棒消毒中間尿道口。 D. 清潔：另持 3 支蒸餾水棉棒，依上述步驟清潔。	◆ 鋪無菌洞巾法：(如下圖) 1.兩手各持無菌洞巾之一頂角，吸水面朝上，防水面朝下。 2.將頂角稍向內捲包住兩手，以防雙手接觸到病人之大腿而污染手套。 3.將洞巾之洞口對準尿道口鋪平。  ◆ 男病人之消毒步驟： 一手持紗布，輕輕提握病人之陰莖使其角度呈 60~90°，並將包皮往後推，先以優碘棉棒消毒，由尿道口周圍環形消毒龜頭與陰莖前段，再用蒸餾水棉棒清潔。
(6)教導病人微張口作深呼吸，分散其注意力。	
(7)將導尿管輕插入女病人之尿道，長約 2-3 吋 (5-7 公分)。	男病人之尿道，長約 7-8 吋 (17-20 公分)。
(8)確定導尿管可適當引流尿液後，一隻手固定導尿管，一隻手拿取裝好 10c.c.蒸餾水之針筒打入導尿管前端之氣囊，打入氣囊後輕輕拉導尿管到固定位置。固定於膀胱內，輕拉導尿管，確認固定。(不可回推)	若導尿管包裝上有標示固定氣囊之水量，則以標示為主。 男病人最後需將包皮復位。
(9)取 Mefix 膠布固定於女病人大腿內側（如右圖所示）。	固定尿管時需留部分長度，男病人固定於下腹部或大腿前側（如下圖所示）。 
(10)留取無菌尿液檢體	從蓄尿袋將尿液放入無菌尿盒，(因目前仍處無菌系統中)
(11)移除洞巾清潔病人外陰部。	可用撕除洞巾或將尿袋從洞巾洞口穿出方式移除，移除時，尿袋不要高於膀胱防止逆流
(12)將蓄尿袋固定於床邊，其位置須低於病人膀胱之高度，且勿觸及地面，管口須隨時關閉並視	每隔 8 小時或滿 1000 c.c.時應排空，集尿袋不可超過 8 分滿，應有個人專屬尿壺或容器，倒

主題名稱	存留導尿技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A26	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	5/9

步驟	說明
需要排除尿液，以免逆流而感染。	尿時，蓄尿帶之管口不可碰觸到尿壺。
(13)隨時檢查引流系統是否受壓迫或曲折，並評估病人有無不適之主訴（如：疼痛、發燒）及蓄尿袋內尿液之性質（如：尿量減少、顏色混濁或呈血色、惡臭）。	視病人病況，若無限水，則鼓勵其每天攝取2000-3000 c.c.體，及攝取蔓越梅汁或富含維生素 C 的食物，以減少感染機會。
6.將導尿包及用物丟至感染性垃圾桶。	
7.脫除無菌手套，進行時機 3 暴露病人體液風險後洗手。	
8. 尿袋背面寫上更換日期。	導尿管更換期限一星期一次、矽質(silicon)材質導尿管一個月更換；導尿管如有，阻塞、滲透、髒汙或感染等情形或尿袋破損皆須應立即更換，且導尿管及尿袋應一起更換。 
9. 整理環境及用物：	
(1) 協助病人穿好衣褲，採舒適臥位並整理環境。	
(2) 移去圍簾。	
10. 離開病房後，進行時機 4 接觸病人後洗手。	
11. 完成 HIS 系統/「護理執行」/「執行狀態」核簽“已執行”。	
12. 記錄：時間、導出量、尿液顏色、性質及病人反應等，於護理系統/「管路管理」登錄置入及移除日期。	需記錄輸出量者，則先用尿壺測出導出量後，再將之倒除。

（四）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

主題名稱	存留導尿技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A26	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	6/9

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 蘇麗智等(2022)·存留導尿法與其護理，實用基本護理學（九版，410-414 頁）·台北：華杏。
- (二) 蘇麗智等合著(2022)·存留導尿法與其護理·實用基本護理學(九版，468-478 頁)·台北：華杏。
- (三) 蘇麗智等合著(2015)·存留導尿法與其護理·實用基本護理學下冊（七版，417-423 頁）·台北：華杏。
- (四) 院內感染管制委員會_212070-AAA-W-012_導尿管放置之感染管制政策，於 89 年 02 月 25 日制定，113 年 5 月 30 日修訂。

七、附件

(略)

主題名稱	存留導尿技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A26	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	7/9

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
89.01.31	1.0	新制定	89 年 01 月 31 日護理部技術標準委員會通過
99.01.04	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
99.11.03	2.1	修改說明內容	100 年 11 月 03 日護理部技術標準委員會通過
101.04.11	2.2	1.增加準備用物圖片文字說明。 2.修改病人辨識方法：確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日、病歷號。	101 年 04 月 11 日護理部技術標準委員會通過
102.02.20	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
103.03.18	3.1	1.說明(三)步驟及要點說明 5.(10)新增：每隔 8 小時或滿 1000 cc 時應排空及步驟 7.清潔用物送消改為清潔導尿包器械送消。 2.更新參考資料版本。	103 年 03 月 18 日通過護理部技術標準委員會。
104.03.17	3.2	1.第三項第(二)(三)目步驟及要點說明內容部份修辭。 2.更新參考資料。	104 年 03 月 17 日護理部技術標準委員會通過
105.03.15	3.3	1. 增修第三項第(一)目之 1(2)病人辨識說明。 2. 第三項第(三)目之 5(7)步驟內容增修說明：以免氣囊壓迫膀胱頸產生尿液感。 3. 更新第六項參考資料。	105 年 03 月 15 日護理部技術標準委員會通過
105.12.20	3.4	1. 原導尿包改為拋棄式導尿包，故修正用物準備及第三項第(三)目內相關內容。 2. 新增第六項參考資料。	105 年 12 月 20 日護理部技術標準委員會通過
106.03.14	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.03.22	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.03.18	3.5	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第四日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 03 月 18 日護理技術組會議通過； 108 年 04 月 10 日護理長會議通過；108

主題名稱	存留導尿技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A26	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	8/9

修正日期	版本	修正說明	備註
			年 04 月 23 日督導會議通過公布。
109.03.16	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
109.10.20	3.6	依『感委會_212070-ABA-P-003_導尿管放置之感染管制政策』修訂說明內容 1. 第三項第一目之 3、4 新增說明內容。 2. 第三項第二目之 1 修訂說明內容並新增之 9。 3. 第三項第三目之 5 新增會陰沖洗準備用物。 4. 第三項第三目步驟及要點說明修訂部份說明內容。	109 年 09 月 21 日護理技術組會議通過； 109 年 10 月 14 日護理長會議通過；109 年 10 月 20 日督導會議通過公布。
110.03.15	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.03.08	3.7	第三項第三目之 1(3)新增確認同意書是否簽署完整。	110 年 12 月 13 日護理技術組會議通過； 111 年 01 月 12 日護理長會議通過；111 年 03 月 08 日督導會議通過公布。
111.03.21	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.03.20	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.10.17	3.8	1. 第三項第二目用物準備修訂。 2. 第三項第三目步驟及要點說明修訂。	112 年 09 月 18 日護理技術組會議通過； 112 年 10 月 11 日護理長會議通過；112 年 10 月 17 日督導會議通過公布。
113.03.18	3.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.03.17	3.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
115.04.07	3.9	1.主題名稱「法」改為「技術」。 2.第一項增加：CAUTI Bundle 及洗手五時機	114 年 12 月 15 日、 115 年 03 月 16 日護

主題名稱	存留導尿技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A26	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	9/9

修正日期	版本	修正說明	備註
		3.第三項第二目第 3 點增加：Aqua 2%CHG 水溶液。 4.第三項第三目內容依 bundle 加入洗手五時機內容修訂。 5.第六項參考資料修訂。	理技術組會議通過； 115 年 03 月 18 日護理長會議通過；115 年 04 月 07 日督導會議通過公布。